

1 薬剤の分類マップ

間質性肺疾患 肺の炎症・線維化	EGFR阻害薬 ゲフィチニブ エルロチニブ オシメルチニブ 抗体薬物複合体(ADC) T-DXd ダトポタマブ デルクステカン その他 エベロリムス ブレオマイシン ゲムシタビン
肝障害 肝細胞障害・胆汁うっ滞	経口TKI(添付文書に警告) ラパチニブ パゾパニブ レゴラフェニブ スニチニブ HBV再活性化に注意 リツキシマブ オビヌツズマブ 化学療法・ステロイド全般
免疫チェックポイント阻害薬 irAEの肺臓炎・肝炎	抗PD-1/PD-L1抗体 ニボルマブ ペムブロリズマブ アテゾリズマブ デュルバルマブ 抗CTLA-4抗体(併用で増加) イピリムマブ トレメリムマブ
確認する検査・予防薬 早期発見と予防	肺 SpO2 胸部画像 KL-6 肝臓 AST・ALT 総ビリルビン HBV再活性化の予防 エンテカビル HBV-DNA測定

経口薬(保険薬局で交付されることが多い) 注射薬

2 重症度(CTCAE Grade)と保険薬局での対応

軽い — 重症度 — 重い

Grade1	Grade2	Grade3
肺臓炎 症状がない、画像所見のみ	肺臓炎 症状があり治療を要する、身の回り以外の生活に支障	肺臓炎 高度の症状、身の回りの生活に支障、酸素を要する
AST・ALT増加 基準値上限の3倍以下	AST・ALT増加 基準値上限の3～5倍	AST・ALT増加 基準値上限の5～20倍
保険薬局での対応 検査値の推移と症状の聞き取りを継続	保険薬局での対応 肺症状は至急受診を勧める。肝機能は処方医へ情報提供	保険薬局での対応 休薬が必要。至急処方医へ連絡

間質性肺疾患を疑う症状(空咳・息切れ・発熱)は、Grade1にかかわらず至急受診につなげる

3 副作用の特徴と発現時期

	開始日	2週	1か月	2か月	3か月	半年～
● ILD(EGFR阻害薬)		開始後4週以内が多い				
● 肝障害(レゴラフェニブ等)		開始後2か月以内が多い				
● ILD(T-DXd)			数週～数か月、時期を問わず			
● 肺臓炎・肝炎(ICI)			数週～数か月、終了後も			
● 非感染性肺炎(エベロリムス)		開始後数週～数か月				
● 肺線維症(ブレオマイシン)				総投与量の増加とともに		
● HBV再活性化				治療中～終了後も		

重篤・特に注意 その他

押さえておきたいポイント

- 間質性肺疾患は症状で気づく。空咳・息切れ・発熱はGrade1にかかわらず至急受診へ
- 肝障害は検査値で気づく。処方箋の検査値で開始後2～3か月の推移を確認
- HBV再活性化は抗ウイルス薬の継続とHBV-DNA測定で防ぐ。漢方薬・健康食品も確認